

RECURSO CÍVEL Nº 5075479-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
RECORRENTE: VICTORIA FALCAO NASCIMENTO (AUTOR)
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)
RECORRIDO: OS MESMOS

ADMINISTRATIVO E SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMO - DIABETES MELLITUS TIPO 1 - INSULINA GLARGINA 100U/ML (LANTUS® OU BASAGLAR®) E MONITOR DE GLICOSE FREESTYLE® LIBRE (LEITOR E SENSORES) - INSULINA DE AÇÃO PROLONGADA INCORPORADA AO SUS, MAS NÃO FORNECIDA CONCRETAMENTE - REJEIÇÃO AO TRATAMENTO PADRONIZADO - APRESENTADO LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE, ATESTANDO A DA IMPRESCINDIBILIDADE OU A NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS - MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA - INSUMO NÃO INCORPORADO, IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - PROVA DE HIPOSSUFICIENCIA - TEMA 106 DO STJ - TEMA 6 DO STF - RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA UNIÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA UNIÃO. Sem custas para ambas as partes, ante isenção legal. Condeno a União em honorários, os quais fixo em R\$ 500,00. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, ficam suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, inclusive ao MPF. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

5075479-02.2024.4.02.5101

510015641372 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5075479-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
RECORRENTE: VICTORIA FALCAO NASCIMENTO (AUTOR)
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)
RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e os contracheques apresentados, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

***ENUNCIADO 119** - "O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50."*

Em suma, a pretensão consiste na condenação dos réus no fornecimento do medicamento e insumos Insulina Glargina (Basaglar), Monitor de Glicose Freestyle Libre Leitor e Sensor FreeStyle Libre, nas quantidades e pelo tempo conforme prescrição do médico responsável.

A autora, com **22 anos** de idade, é acompanhada pelo **Hospital Universitário Clementino Fraga Filho** e apresenta o diagnóstico de **Diabetes Mellitus tipo 1** (CID 10: E 10.0), com quadro clínico instabilidade glicêmica com hiperglicemia capazes de levar a insuficiência renal e cegueira, bem como, hipoglicemias graves capazes de levar a convulsões e morte, devendo fazer uso de **Insulina de Ação Prolongada (BASAGLAR OU LANTUS) 100UI/ML (4 Canetas ou 2frascos/mês ou 40 unidades uma vez ao dia)**. Vide fl. 21 do evento 1, ANEXO2.

O juízo de origem julgou **parcialmente procedente o pedido**, nos seguintes termos:

"Pelo exposto, CONFIRMO A DECISÃO ANTECIPATÓRIA (evento 13) e:

1 - JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar, solidariamente, a União Federal, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro a fornecerem à parte autora o medicamento Insulina Glargina (Basaglar ou Lantus®), conforme prescrito pela médica assistente (evento 1, ANEXO2, página 21), em quantidade necessária inicialmente para seis meses, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R\$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de mora injustificada, a contar do final do prazo desta sentença. Direcciono ao Estado do Rio de Janeiro o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento a autora, por ser o Ente mais capacitado para tal, bem como tendo em vista o referenciado no ofício Of.SES/ASSADJ Nº4595, de 19 de fevereiro de 2024, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ, sem prejuízo de posterior ressarcimento pelos outros réus, a se verificar na fase de cumprimento da sentença.

2 - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de fornecimento dos insumos glicosímetro intersticial (FreeStyle® Libre) com sensor."

A parte autora e a União apresentaram recursos.

A autora requer a concessão do insumo glicosímetro intersticial (FreeStyle® Libre) com sensor.

A União requer a improcedência integral dos pedidos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que a obrigação da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária, de maneira que qualquer um dos referidos entes federativos pode figurar no polo passivo de demanda em que se objetiva assegurar o fornecimento ou custeio de medicamentos ou tratamento médico. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(STF, Pleno, RE 855178 RG/PE, Relator Ministro LUIZ FUX, publicado em 16/03/2015).

Além disso, o entendimento quanto à legitimidade da União e, *mutatis mutandis*, também dos demais entes federados encontra-se, inclusive, sedimentado no Enunciado nº 43 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais desta Seção Judiciária do Rio de Janeiro, *in verbis*:

Enunciado 43: "A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS".

A descentralização administrativa dos serviços e recursos financeiros tem por fim tão somente o de melhorar a qualidade e o acesso à saúde, e não pode se prestar para afastar a responsabilidade de quaisquer dos entes. Pelo contrário, reforça a responsabilidade solidária, pois indica o trabalho conjunto para perseguir o fim constitucional.

O exame da questão passa pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, na STA em AgRg 175, onde aquele explicou que o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em evidências”, de modo que **um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela**, pois tende a contrariar consenso científico vigente. Mais do que isso: a gestão do SUS, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações de saúde, só se torna viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. **Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS**, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada.

Dessa forma, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida, **sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente**.

Com isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que **o deferimento pelo Judiciário de medicamento extraordinário fora do âmbito do SUS, deve ficar restrito a hipóteses de rara e especial excepcionalidade**:

(a) quando a enfermidade do paciente não for tratada pelo SUS, ou;

(b) quando o tratamento/medicamento disponibilizado pelo SUS não tiver eficácia comprovada no caso concreto.

Caso não se inclua nestas hipóteses, **pelo fato de o SUS disponibilizar gratuitamente outros medicamentos para o tratamento da enfermidade**, não há que se falar em deferimento pelo Judiciário, sob pena de prejudicar, conforme já explicitado, o acesso universal e isonômico à saúde. E isto porque a opção pelo medicamento listado leva em consideração outros fatores: o **custo, a eficácia comprovada e a incidência sobre a patologia tratada, de modo a beneficiar a maior parte da população**. Assim, a Administração Pública adota critérios plausíveis quando incorpora um medicamento à listagem daqueles que serão gratuitamente distribuídos, sendo inviável ignorá-los a fim de satisfazer a demanda de uma pessoa isoladamente.

Por tal razão, não cabe ao Judiciário ingerência sobre prioridades estabelecidas pelo Estado, que envolvam políticas públicas para garantir o regular atendimento e fornecimento de medicação na rede de saúde, sob pena de, por via transversa, criar situação de inaceitável desigualdade em relação aos demais usuários do SUS. O posicionamento acima é compartilhado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

*CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ESPECÍFICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. União, Estados e Municípios, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são responsáveis solidários pelo fornecimento de medicamentos. **Não faz jus ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público o paciente que não se desincumbe de comprovar a real necessidade dos mesmos e a impossibilidade de substituí-los por outros disponibilizados pelo SUS.** Inversão da sucumbência, que é fixada na esteira dos precedentes da Turma. Prequestionamento estabelecido pelas razões de decidir. Apelações e remessa oficial providas. (apelação nº 0006160-45.2008.404.7200)*

Conclui-se, portanto, que é necessário demonstrar que **o tratamento fornecido pelo SUS não é adequado para controle da enfermidade da parte requerente para que, então, possa se fugir ao padrão e deferir terapia diversa, não havendo margem para escolha de tratamento que mais lhe aprouver**, desconsiderando as terapias já ofertadas pela Administração Pública, a partir da mera discricionariedade médica, ainda que o profissional esteja vinculado ao SUS.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de representativo de controvérsia (tema 106)[1], no sentido de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença **cumulativa** dos seguintes requisitos[2]:

(a) *Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*

(b) **incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito**;

(c) *existência de registro na ANVISA do medicamento, **observados os usos autorizados pela agência**.*

De outro giro, é dizer: o Superior Tribunal de Justiça ratificou os requisitos já fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange à prova de ineficácia do tratamento dispensado pelo SUS, e incluiu 2 novos, quais seja, a hipossuficiência econômica do requerente e o registro

do medicamento na ANVISA, afastando, assim, o fornecimento de fármacos cuja eficácia não tenha sido atestada por órgãos de controle.

Em 26/09/2024, sem modulação dos efeitos da decisão, em sede de repercussão geral, no âmbito do RE 566471, Redator do acórdão: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, o STF fixou as seguintes teses (**Tema 6 da repercussão geral** - RE. DJE divulgado em 27/09/2024, publicado em 30/09/2024.):

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficial aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Por fim, determinou, tal como no Tema 1.234, que essas teses sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação (Enunciado publicado no DJE e no DOU em 03/10/2024):

Súmula vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A tese do Tema 6 - STF estabelece uma regra geral: a ausência de um medicamento nas listas oficiais do SUS impede, em princípio, seu fornecimento por decisão judicial (item 1 da tese). Trata-se de uma deferência judicial às políticas públicas de saúde fixadas pelo Poder Executivo, dado que as listas não são criadas casuisticamente, mas, sim, a partir de análises técnicas embasadas em critérios técnico-científicos e de custo-efetividade dos fármacos.

Entretanto, o STF estabeleceu os parâmetros para excepcionalização da referida referida regra, quais sejam (item 2 da tese):

- 1. A comprovação de negativa administrativa prévia;**
- 2. A demonstração de ilegalidade ou omissão no processo de incorporação do medicamento;**
- 3. A inexistência de alternativas terapêuticas no SUS;**
- 4. A comprovação científica robusta da eficácia e segurança do medicamento;**
- 5. A demonstração da imprescindibilidade do tratamento;**
- 6. A comprovação da hipossuficiência financeira do paciente.**

A alínea a do item 2 da tese remete ao item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral (" (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;"), o qual prevê que:

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, **deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.**

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

No caso concreto, a Autora, 22 anos, apresenta diagnóstico de **diabetes mellitus tipo 1**. Relata uso das insulinas NPH + Regular até 2023, **sem boa resposta terapêutica**. O médico assistente prescreve insulina glargina (Lantus®) 04 canetas ao mês, insulina asparte (lispro®) 04 canetas ao mês e os insumos glicosímetro intersticial (FreeStyle® Libre) com sensor, 01 unidades a cada 14 dias.

- **Quanto à Insulina Glargina (Bsaglar ou Lantus®):**

A Insulina de ação prolongada - Glargina (Lantus®) é um antidiabético que contém uma insulina humana análoga produzida por tecnologia de DNA-recombinante, utilizando Escherichia coli como organismo produtor. Está indicada para o tratamento de Diabetes mellitus tipo 2 em adultos e também é indicada para o tratamento de Diabetes mellitus tipo 1 em adultos e em crianças com 2 anos de idade ou mais que necessitam de insulina basal (longa duração) para o controle da hiperglicemia.

Os membros da **CONITEC** presentes na 75ª reunião ordinária do plenário do dia 13/03/2019 deliberaram por unanimidade **recomendar a incorporação da insulina análoga de ação prolongada (Glargina)** para o tratamento de **diabetes mellitus tipo I**, condicionada ao custo de tratamento igual ou inferior ao da insulina NPH na apresentação de tubete com sistema aplicador e mediante protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Considerou-se que as **insulinas análogas de ação prolongada tem eficácia e segurança semelhantes a insulina humana NPH, mas apresentam custos elevados**. Dessa forma, a incorporação das insulinas análogas de ação prolongada é mediante custo de tratamento igual ou inferior ao da insulina NPH (tubete com sistema aplicador) e vinculada ao protocolo clínico e diretrizes terapêutica:

PORTARIA Nº 19, DE 27 DE MARÇO DE 2019 Torna pública a decisão de incorporar insulina análoga de ação prolongada para o tratamento de diabetes mellitus tipo I, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS

Art. 1º Fica incorporada insulina análoga de ação prolongada para o tratamento de diabetes mellitus tipo I, condicionada ao custo de tratamento igual ou inferior ao da insulina NPH na apresentação de tubete com sistema aplicador e mediante protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias. Apesar de decorrido o prazo citado no artigo 20 da PORTARIA Nº 19, DE 27 DE MARÇO DE 2019 a insulina glargina ainda não está disponível através do SUS.

Conforme Parecer do NAT (evento 46, PARECER1), as Insulinas análogas de ação prolongada (**grupo da insulina pleiteada glargina**) **foram incorporados ao SUS no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento do**

diabetes mellitus tipo I, listado na REMUME perfazendo o grupo de financiamento 1A do referido componente: medicamento com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estado.

Contudo, o medicamento Insulina glargina ainda não integra, uma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro.

Cabe ressaltar que o Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêutica (PCDT) para o manejo do diabetes mellitus tipo 1, o qual preconiza, dentre outros critérios, o uso da associação insulina de ação rápida + insulina NPH, por pelo menos 03 meses, antes de introduzir a insulina de ação prolongada.

No momento, o SUS também disponibiliza, para tratamento do diabetes mellitus tipo 1, no âmbito da Atenção Básica, a insulina NPH em alternativa à insulina glargina (Lantus®).

Entretanto, conforme destacado pelo NAT: cabe observar que no documento médico acostado aos autos processuais (Evento 1_ ANEXO2, pág. 21) foi relatado que a Autora “... *Apresenta dificuldade de controle glicêmico a despeito do uso de Insulina NPH e Regular (não apresentou sucesso com essa terapia)*”.

O órgão consultivo concluiu que: ***entende-se que a insulina NPH padronizada não configura uma opção terapêutica no presente momento.***

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto ao fornecimento desta insulina. Afinal, o medicamento está incluído em bula para o tratamento do quadro clínico apresentado pela autora, possui registro na ANVISA, foi incorporada ao SUS por meio de PCDT publicado pela CONITEC. **Entretanto, não é fornecido em concreto por falha administrativa.**

- **Quanto ao insumo glicosímetro intersticial (FreeStyle® Libre) com sensor:**

Conforme Parecer do NAT-JUS (evento 46, PARECER1 destes autos), segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, para atingir o bom controle glicêmico é necessário que os pacientes realizem avaliações periódicas dos seus níveis glicêmicos. O automonitoramento do controle glicêmico é uma parte fundamental do tratamento **e este pode ser realizado através da medida da glicose no sangue capilar (teste padronizado pelo SUS) ou pela monitorização contínua da glicose (MGC).** Ponderou que **o método de monitorização Free Style® Libre não está incorporado ao SUS, bem como os estudos científicos sobre essa modalidade de monitorização até o momento não apresentaram evidências de benefício inequívoco** para a recomendação de sua incorporação ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da DM tipo 1, segundo avaliação do Ministério da Saúde. Assim, concluiu que o aparelho FreeStyle® Libre apesar de estar indicado para o manejo do quadro clínico do Autor, Diabetes mellitus tipo 1, com grande variabilidade glicêmica (evento 46, PARECER1, Página 18), **NÃO É IMPRESCINDÍVEL. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.**

De fato, a documentação médica apresentada não apresentou qualquer fundamento para afastar a forma convencional de aferição pela glicemia capilar, método fornecido pelo SUS.

Portanto, quanto aos insumos requeridos, tem-se pela negativa de seu fornecimento.

Apesar dessas ponderações, o Estado do Rio de Janeiro, através de lei, assumiu a obrigação de fornecer gratuitamente a bomba de infusão de **insulina** e parte de seus acessórios aos pacientes com diabetes tipo 1, em acompanhamento regular na rede pública de saúde ou em centros especializados para o tratamento da doença.

O referido direito é garantido pela LEI ESTADUAL Nº 4119, DE 1º DE JULHO DE 2003, conforme modificações introduzidas pela Lei 8342/2019. *In verbis*:

LEI Nº 4119, DE 1º DE JULHO DE 2003.

DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A SUA APLICAÇÃO E À MONITORAÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR AOS PORTADORES DE DIABETES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

D E C R E T A:

Art. 1º - O Estado do Rio de Janeiro manterá em caráter permanente, distribuição gratuita, para os portadores de diabetes, os medicamentos necessários para o tratamento de sua condição e os materiais necessários a sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar.

§ 1º - O Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, selecionará os medicamentos e materiais, com vistas a orientar sua aquisição, bem como publicará anualmente a relação dos mesmos com vistas a dar conhecimento aos interessados.

* I - inclui-se no arsenal terapêutico distribuído pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro as insulinas análogas para tratamento do diabetes tipo 1.

* Incluído pela **Lei 8219/2018**.

* II - Os pacientes que possuem diabetes tipo 1, em acompanhamento regular na Rede Pública de Saúde ou Centro Especializado para o tratamento de Diabetes tipo 1, sediado no estado, terão direito a receber tratamento com Bomba de Infusão de Insulina, de acordo com indicação médica, no estado do Rio de Janeiro.

* Incluído pela **Lei 8342/2019**.

§ 2º - A seleção a que se refere o “caput” deverá ser revista anualmente ou sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico atualizado e à disponibilidade de novos medicamentos, tecnologias e produtos no mercado.

§ 3º - É condição para o recebimento dos medicamentos e materiais citados no “caput” estar inscrito em cadastro especial para diabéticos, em unidade de saúde do Estado.

Com efeito, à luz do Tema 106 do STJ e do Tema 6 do STF, o pedido não pode ser reconhecido em face dos demais entes, ante a ausência de imprescindibilidade e comprovação da ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS.

Por essas razões, a manutenção do indeferimento, em face da União, é medida que impõe.

Todavia, o ERJ assumiu a responsabilidade pelo seu fornecimento, criando para a parte recorrente o direito ao seu fornecimento, agora, na via administrativa uma vez que pediu o insumo, indevidamente, nesta ação incluindo ainda, inadvertidamente, o ERJ.

Apesar do fornecimento de bomba de infusão de insulina ser garantido pelo ente estadual, não é dado à parte a preferência ou escolha por marcas específica. Não havendo comprovação da ineficácia da bomba de insulina eventualmente fornecida pelo Estado, não é possível deferir a autora aquela que seja de preferência de seu médico assistente sem razões concretas da diferenciação. E não se tratando de insumo incorporado ao SUS, mas cuja responsabilidade de fornecimento foi assumida pelo ERJ, caberá a autora requerer administrativamente o insumo ao mesmo.

[1] Lei nº 8.080/90:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea *d* do inciso I do art. 6º consiste em: **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravamento à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

[2] ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glauco 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a **presença cumulativa dos seguintes requisitos:** (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o

tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
(STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA UNIÃO.** Sem custas para ambas as partes, ante isenção legal. Condeno a União em honorários, os quais fixo em R\$ 500,00. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, ficam suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, inclusive ao MPF. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5075479-02.2024.4.02.5101

510015641370 .V5